УРОК 3. HELICOBACTER PYLORI

Helicobacter pylori – это штамм хелкобактерий, который населяет желудок человека с древности. Данный штамм является жителем нормальной микробиоты человека. Он находится в желудке человека начиная со времен палеолита и является древним неизменным жителем нормальной микробиоты желудка.

Данный штамм есть у 80% взрослого населения планеты и у большинства носителей не обнаруживается никаких симптомов заболеваний, связанных с размножением бактерии.

При нормальном уровне кислотности в желудке Helicobacter pylori размножаться не будет. Ее размножение возникает исключительно на фоне гипоацидности.

При гипоацидности Helicobacter pylori начинает размножаться и приводит к заболеваниям ЖКТ.

Гастрин – это гормон, который участвует в регуляции пищеварения. Он вырабатывается клетками, которые располагаются в слизистой желудка, двенадцатиперстной кишке и в поджелудочной железе.

Хеликобактер - это патоген, который может жить в желудке человека как бессимптомно, так и вызывая хроническое воспаление желудка, что в свою очередь приводит к развитию серьезных заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язвенная болезнь, рак желудка и др.

ГАСТРИТ – это воспаление слизистой оболочки желудка. Одной из основной причиной хронического гастрита, язвенных болезней желудка, двенадцатиперстной кишки и рака является бактерия Helicobacter pylori.

До 80-х годов XX века у врачей не было доказательств связи Helicobacter pylori с язвой желудка. Но австралийским ученым удалось доказать эту связь в результате эксперимента: им удалось выделить эту бактерию из содержимого желудка, колонизировать ее, и ради эксперимента была выпита взвесь с колоний бактерии человеком, у которого развился гастрит.

С тех пор, появления гастрита желудка связывают в том числе и с размножением этой бактерии и ее нейтрализация в традиционной медицине происходит под воздействием антиБИОтиков. При работе с гастритом используется двух- или трех-ступенчатая терапия по эрадикации (уничтожению) Helicobacter pylori. Одновременно применяются ИПП, которые приводят к гипоацидности, ГЭРБ и связанными с нею симптомами и заболеваниями.

Также в протоколах лечения гастрита с Helicobacter pylori прописано, что больной должен быть пролечен по одной из схем «первой линии», а при неудачном лечении – по одной их схем «второй линии».

ЧТО МЫ ИМЕЕМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

Успешная эрадикация схемой «первой линии» происходит в 20% случаев, тогда как 80% лечения заканчивается не успешно и больной переходит к лечению по схеме «второй линии» (+ еще два антибиотика).

После лечения по схеме «второй линии» полное восстановление слизистой оболочки желудка возникает лишь у 13-15% пациентов.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ БАКТЕРИЕЙ HELICOBACTER PYLORI?

- через слюну (поцелуи, бытовые предметы, косметику, помаду);
- животных (собак, кошек и пр);
- через плохо продезинфицированное медицинское оборудование.

КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОКАЗАНО ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ HELICOBACTER PYLORI?

1. **При осложнении язвенной болезни. Но причиной язвенной болезни не всегда является Helicobacter pylori.**

Причины язвы желудка являются:

- курение натощак;
- употребление спиртного;
- переедание и кусочничество в течение дня;
- повышение кислотности желудочного сока вследствие неадекватных пищевых привычек;
- стресс и нервное перенапряжение.

Helicobacter pylori при язве усугубляет ситуацию.

2. **В анамнезе семейные случаи онкозаболеваний по ЖКТ.**

Всегда нужно оценивать все «За» и «Против» традиционного лечения антибиотиками:

- негативные последствия антибиотиков на ЖКТ;
- дисбиоз и его последствия: СВК, СДК, СИБР и из последствия: дефициты, заболевания на их фоне и возможность появления аутоиммунных заболеваний;
- снижение иммунитета;
- во время лечения антибиотиками, Helicobacter pylori образует биопленку для своей защиты, которые антиботики не в состоянии разрушить;
- прием ИПП (омепразол, рабепрозол, экзомепразол) и их последствия.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИПП:

ИПП – это препараты для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ за счет снижения продукции соляной кислоты посредством блокирования мембранного белка.

ИПП в обязательном порядке назначаются в традиционной схеме лечения Helicobacter pylori.

Если у человека есть действительно повышенная кислотность, которую определили pH-метрией, а не на глаз, потому что есть Helicobacter pylori, тогда применение ИПП оправдано. Но, чаще всего ИПП назначаются всегда, без измерения кислотности в желудке и даже тогда, когда определена пониженная кислотность при атрофическом гастрите.

Многие пациенты отмечают резкое обострение симптомов ГЭРБ и отрыжки на фоне приема ИПП, почему?

1. ИПП подавляют продуцирование кислоты в желудке, которая после отмены ИПП входит в состояние гиперкомпенсации. Кислота начинает заливать желудок, происходит резкое обострение симптомов ГЭРБ и назначение другого препарата ИПП, возникает замкнутый круг.

2. ИПП расслабляет низкий пищеводный сфинктер – мышечное кольцо между пищеводом и желудком. При этом проглоченный воздух может свободно выходить обратно в виде отрыжки.

3. При длительном приеме гастропротектора Де-нол (он должен приниматься строго ограниченное время в виду его накопления в центральной нервной системе и негативного влияния на микрофлору кишечника) возникает множество побочных эффектов: тошнота, рвота, запоры, сыпь, зуд).

ДИАГНОСТИКА HELICOBACTER PYLORI:

- 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori;

- анализ крови на антитела к Helicobacter pylori – просто наличие антител в небольшом количестве будет говорить о том, что в организм в какой-то период жизни столкнулся в данной бактерией. Данный анализ нужно сочетать с уреазным тестом, либо с анализом кала на определение антигена бактерии;

- гастропанель. В состав гастропанели входят четыре биомаркера: специфические белки пищеварительного тракта пепсиноген I и II, гастрин-17 и антитела класса IgG к Helicobacter pylori.

- определение антигена Helicobacter pylori в кале – золотой стандарт исследования и самый точный анализ для выявления бактерии.

НУТРИЦЕВТИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ С HELICOBACTER PYLORI

(все препараты принимаем вместе не меньше 4-х недель).

1. РАБОТА С ПИТАНИЕМ И ДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ ИЛИ ПОНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЗНАЧАЮТСЯ НУТРИЦЕВТИКИ.

Нутрицевтики ниже показали огромную эффективность в лечении Helicobacter pylori по сравнению с антибиотиками.

2. ХЕЛИНОРМ – аптечный препарат, обладающий высокой эффективностью. Это инновационное средство для борьбы с бактериями Helicobacter pylori. Его основное вещество «PylopassTM» - это инактивированные бактерии пробиотического штама Lactobacillus Reuteri, которые распознают поверхностные рецепторы клеточной стенки Helicobacter pylori, связываются с ними и выводятся через ЖКТ. При приеме Хелинорма убираем запоры.

3. BIOFILM DEFENSE (нутрицевтик).

Бактерия Helicobacter pylori умеет создавать биопленку (слизистое вещество), которая защищает ее от антибиотиков. Антибиотики не в состоянии ее разрушить и под действием антибиотиков погибают только неприкрытые биопленкой бактерии. Biofilim Defense содержит ферменты, которые расстворяют биопленку и способствуют удалению бактерии.

КАК ПРИНИМАТЬ?

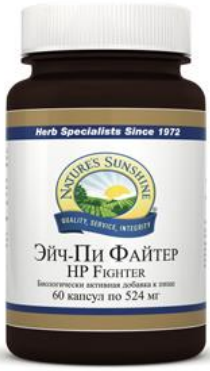
По 1 капсуле в день между завтраком и обедом.

Принимать не меньше 4 недель или на всем протяжении лечения.

4. ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПРЕПАРАТОВ:

ЭЙЧ-ПИ-ФАЙТЕР (сетевой препарат NSP, есть на Ozon и Wildberies, при камнях в желчном пузыре проконсультироваться с врачом) и **GI-ENCAP** (нутрицевтик).

В каждом препарате есть деглициризированная солодка (DGL), которая имеет противовоспалительный эффект и которая показана при язвах и эрозиях желудка, а также подавляет Helicobacter pylori.



КАК ПРИНИМАТЬ?

1-2 капсулы 2 раза в день во время приема пищи.

Рекомендуется дополнительный прием жидкости не менее 1-2 стаканов в день.

или

КАК ПРИНИМАТЬ?

Принимать 1-2 капсулы в день во время еды.

или

ДЕГЛИЦИРИЗИНАТ СОЛОДКИ – глицирризированная кислота убирает боль и тошноту, залечивает слизистую желудка, уменьшает H.Pylori на 25%, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

ДЕГЛИЦИРРИЗИНАТ СОЛОДКИ

КАК ПРИНИМАТЬ?

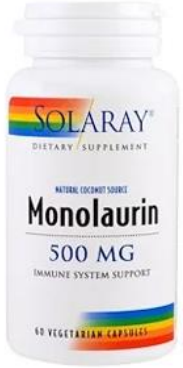
Разжевывать по 1 таблетке 1-3 раза в день за 20 минут до каждого приема пищи.

Из ТРЕХ ПРЕПАРАТОВ НУЖНО ВЫБРАТЬ ОДИН И ПРИНИМАТЬ ЕГО НЕ МЕНЬШЕ 4-Х НЕДЕЛЬ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО СРОКА ЛЕЧЕНИЯ.

5. МОНОЛАУРИН (нутрицевтик) – это моноэфир монолауриновой кислоты кокосового масла, который поддерживает иммунную систему, эффективен при лечении бактериальных, вирусных и грибковых заболеваниях.

Наибольшую активность монолаурин оказывает на грамположительные бактерий:

- Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori);
- Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus);
- Стрептококки (Streptococcus);
- Микобактирии (Mycobacterium), вызывают такие болезни как туберкулёз, лепру, микобактериозы;
- Хламидии (Chlamydia);
- Боррелии (Borrelia, вызывают болезнь Лайма).



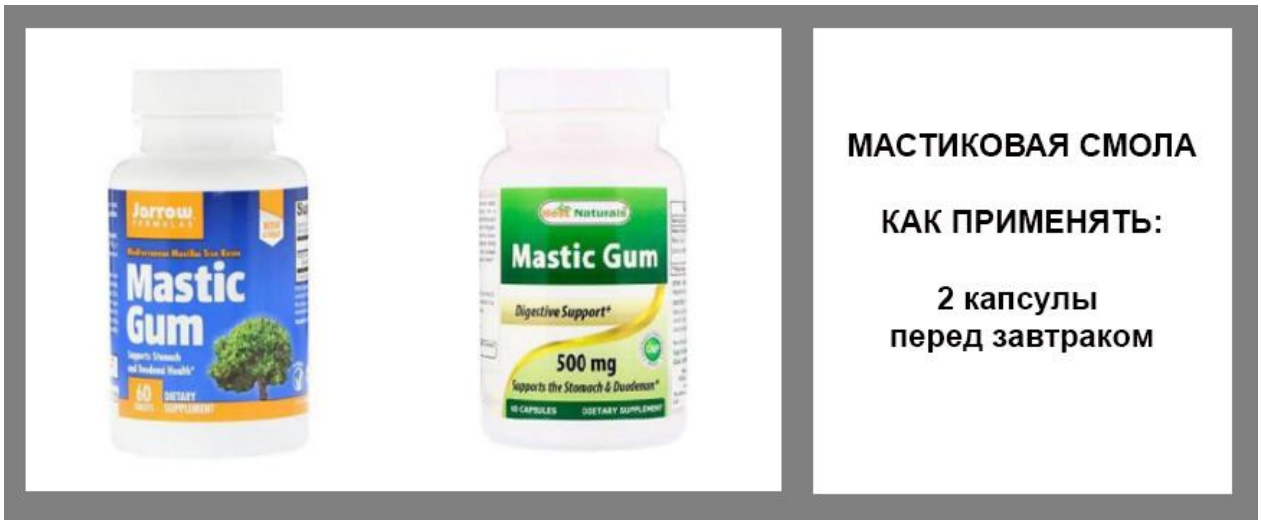
КАК ПРИНИМАТЬ?

1 капсула три раза в день с едой или стаканом воды.

Не принимать с горячими жидкостями.

ПРИНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 4-Х НЕДЕЛЬ.

6. **МАСТИКОВАЯ СМОЛА (Mustic Gum)** – соединения мастиковой смолы являются природными антибиотиками и антисептиками. Уменьшает воспаление не только при ГЭРБ, но и при болезни Крона.



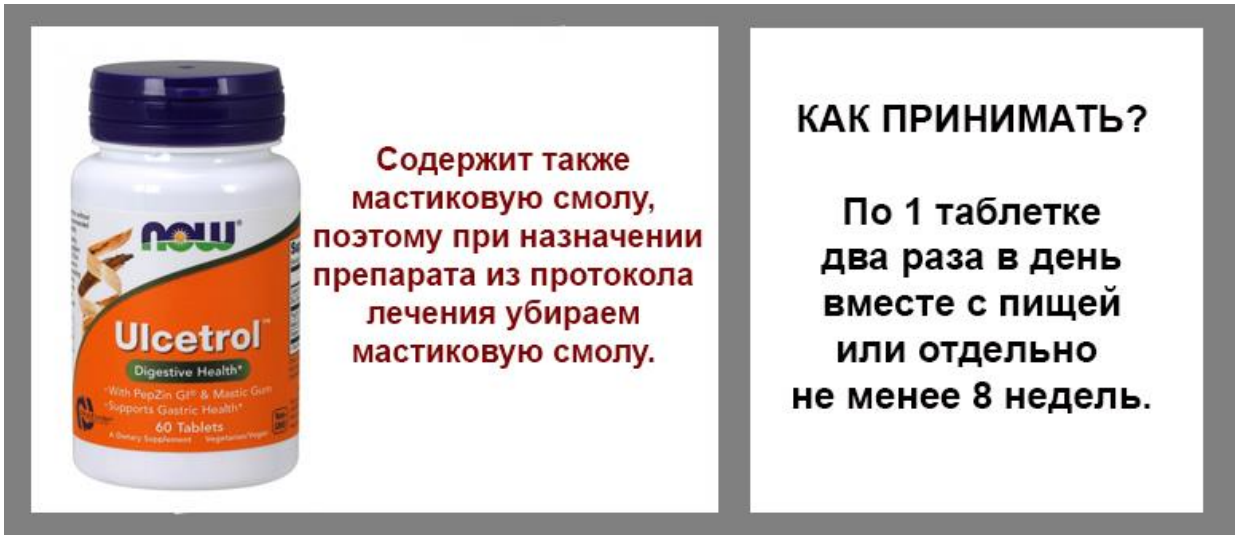
ПРИНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 4-Х НЕДЕЛЬ.

7. **ПРИ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ТАКЖЕ В ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН ИЗ НУТРИЦЕВТИКОВ: ULCETROL** или **ACID SOOTH** (нутрицевтики) – в этих препаратах содержится цинк L-карнозин (специальная форма цинка, которая укрепляет слизистую оболочку желудка, которая является буфером при повышенной кислотности желудка).

ПРИНИМАТЬ ОДИН ИЗ НУТРИЦЕВТИКОВ НЕОБХОДИМО

МИНИМУМ 8 НЕДЕЛЬ.

Эти два препарата регулируют уровень кислотности и являются альтернативой ИПП.



или

ACID SOOTHE – содержит ферменты, лист папайи и другие растительные средства для поддержания оптимального пищеварения и облегчения симптомов, связанных с эпизодическими желудочно-кишечными расстройствами. Zinc Carnosine способствует укреплению слизистой оболочки желудка, действуя как буфер для желудочной кислоты.

или

ЦИНКА КАРНОЗИН (Zinc-L-Carnosine) – снижает кислотность, заживляет слизистую на 75%, обладает одним из лучших гастрозащитных эффектов и работает с нейтрализацией бактерии Helicobacter Pylori. Также данный нутрицевтик очень эффективен при язвенном колите.

ЦИНКА КАРНОЗИН

КАК ПРИНИМАТЬ?

По 2 капсулы 2 раза
в день за 30 минут
до еды
(можно 1 раз перед сном)

8. САХАРОМИЦЕТЫ БУЛАРДИ – это вид дрожжей, которые не заселяют кишечник человека и проходят транзитом, улучшают показатели микробиома и усиливают действие препаратов против Helicobacter Pylori, помогают наладить процесс пищеварения.

Отлично работают с:

- СИБР (синдром избыточного бактериального роста);
- СДК;
- с грибковыми инфекциями;
- дисбиозом, т.к. подавляют рост условно-патогенной флоры;
- помогает нормализовать стул;
- устраняет вздутия, запоры, спазмы в кишечнике;
- работает после антибиотико-терапии, химиотерапии, гормональной терапии подавляя условно-патогенную флору;
- при «синдроме путешественника» (запоры во время поездок – пропить неделю);
- назначается также при болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, а также других аутоиммунных заболеваниях;
- при кожных заболеваниях (от АКНЕ до хронических заболеваний кожи);
- при отравлениях (недельный курс).

Jarrow Formulas, Сахаромицеты Буларди 90 растительных капсул

Произведено джэрроу формулас

739 Отзывы | 38 вопроса(ов)

В наличии

Количество в упаковке: **90 штук**

30 штук	90 штук	180 штук
₽604.95	₽1,172.64	₽2,080.40

Данный препарат отлично работает при СИБР, СДК, диарее и неоформленном стуле.

Как принимать?

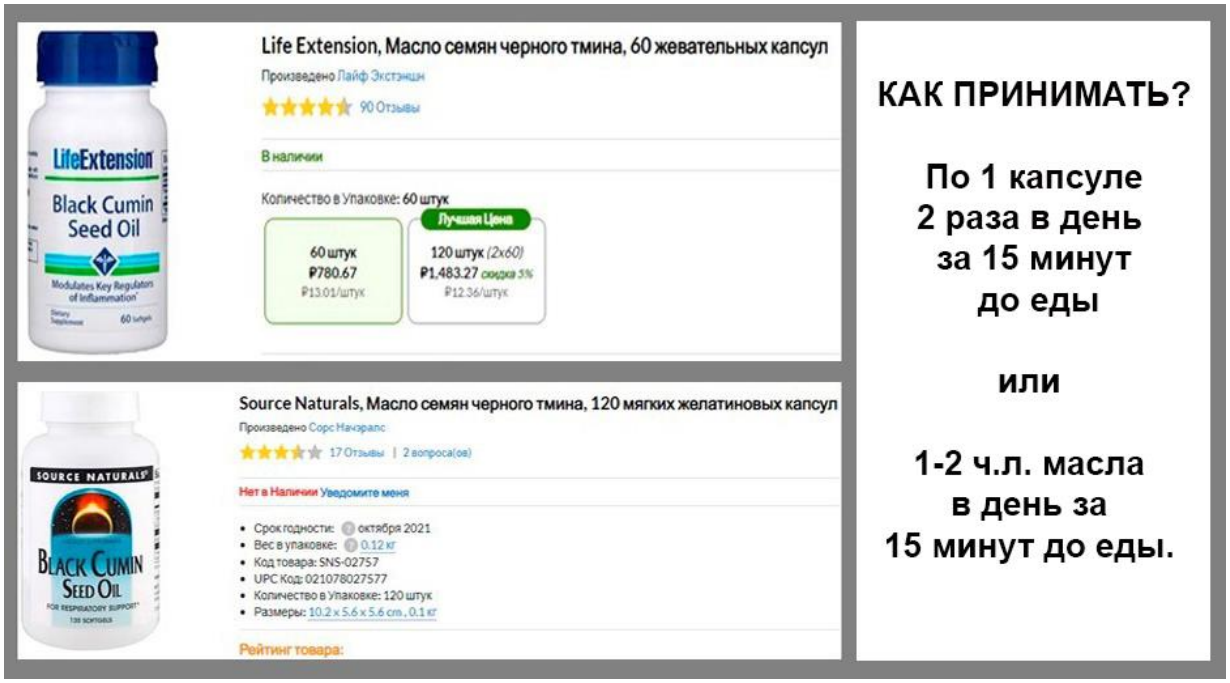
По 1 капсуле утром и вечером запивая водой до или после еды.

Принимать до устранения симптомов (1-2 месяца).

9. МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОГО ТМИНА. Черный тмин - это растительный антиоксидант, который имеет сильные противовоспалительные свойства и хорошо работает с нейтрализацией Helicobacter pylori.

ВНИМАНИЕ: С осторожностью применять при желчнокаменной болезни, при мелких подвижных камнях в желчном пузыре. Можно применять при больших и не подвижных камнях после консультации с врачом.

!!! ВАЖНО!!! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ С ½ Ч.Л. МАСЛА В ДЕНЬ ДО ЕДЫ ЗА 15 МИНУТ, ЗАТЕМ ПОСТЕПЕННО ПОРЦИЮ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ ДО 2-Х Ч.Л. В ДЕНЬ ЗА 15 МИНУТ ДО ЕДЫ И ПИТЬ ДО ПРОХОЖДЕНИЯ СИМТОМАТИКИ (количество раз в день определяется индивидуально по переносимости масла).



ПРИНИМАТЬ МАСЛО НЕ МЕНЕЕ 4-Х НЕДЕЛЬ

ВСЕ ЭТИ СРЕДСТВА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕ ОКАЗЫВАЮТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АНТИБИОТИКОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО НАЗНАЧАТЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ, А НЕ ПРОСТО ТАК, «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Расскажите все, что вы знаете о бактерии Helicobacter pylori.
2. Что такое гастрит?

3. Как удалось обнаружить связь гастрита с бактерией Helicobacter pylori?
4. К каким заболеваниям ведет гипоацидность и размножение бактерии Helicobacter pylori?
5. Как уничтожают бактерию Helicobacter pylori в традиционной медицине? К чему это приводит?
6. В каких случаях допустимо применять антибиотикотерапию?
7. Расскажите о последствиях назначения ИПП.
8. Как можно диагностировать размножение бактерии Helicobacter pylori? Какой самый точный способ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Пропишите на отдельном листке схему лечения гастрита у человека с пониженной кислотностью и бактерией Helicobacter pylori.
2. Пропишите на отдельном листке схему лечения гастрита у человека с повышенной кислотностью и бактерией Helicobacter pylori.
3. Какие рекомендации по питанию вы дадите этим двум пациентам?